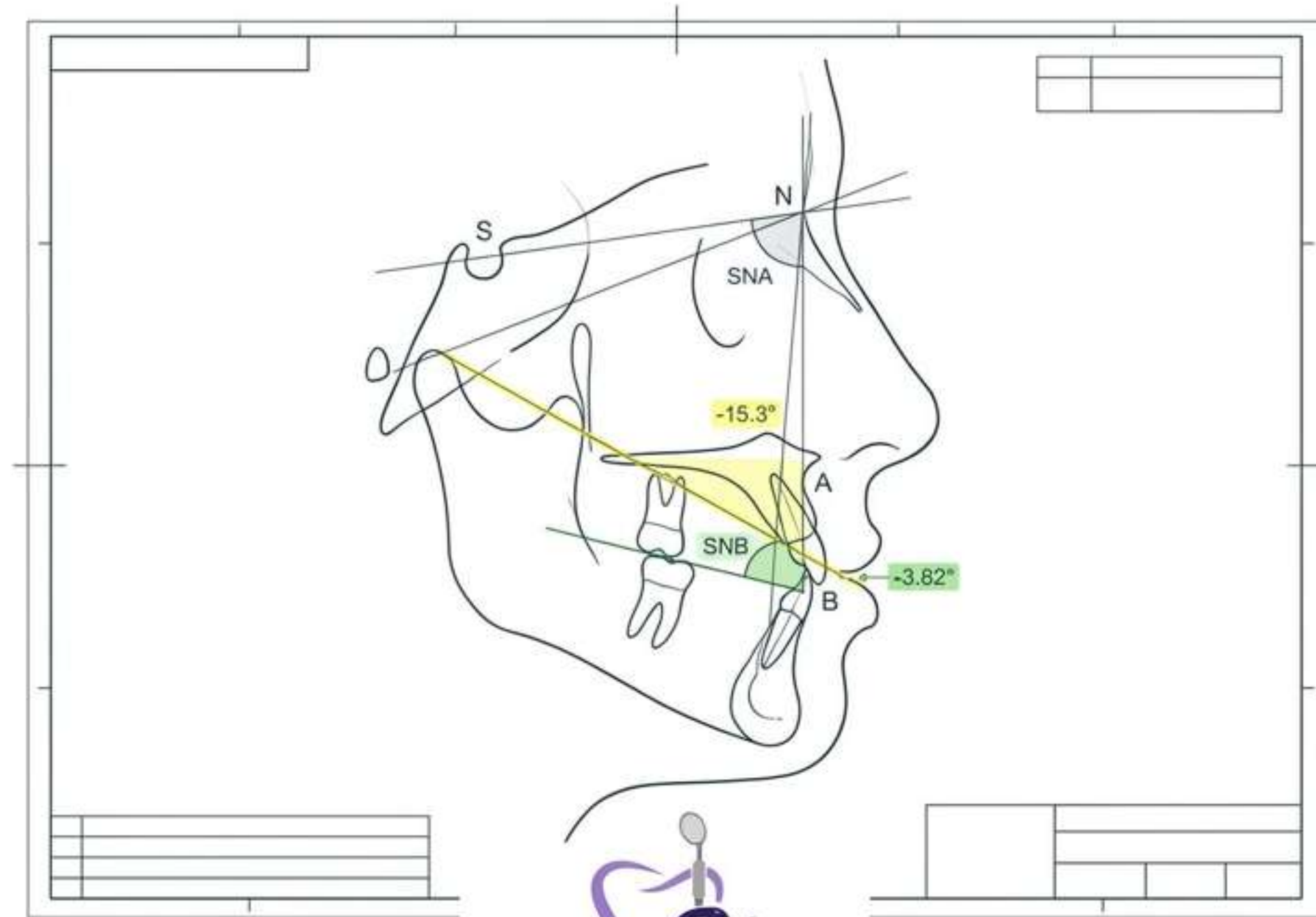


Le Diagnostic des Anomalies Basales du Sens Sagittal : MA CLASSE III

Blueprint Clinique Complet & Guide d'Examen (Zéro Omission)



ANALYSE STRATÉGIQUE DES EXAMENS (CLASSE III)

THÈMES LES PLUS RÉPÉTÉS (TOP TARGETS) :

- La **Manœuvre de DENEVREZE** (Différenciation lésion squelettique vs fonctionnelle).
- Les **valeurs céphalométriques de base** (SNA, SNB, ANB).
- L'**étiologie linguale** (Langue basse).



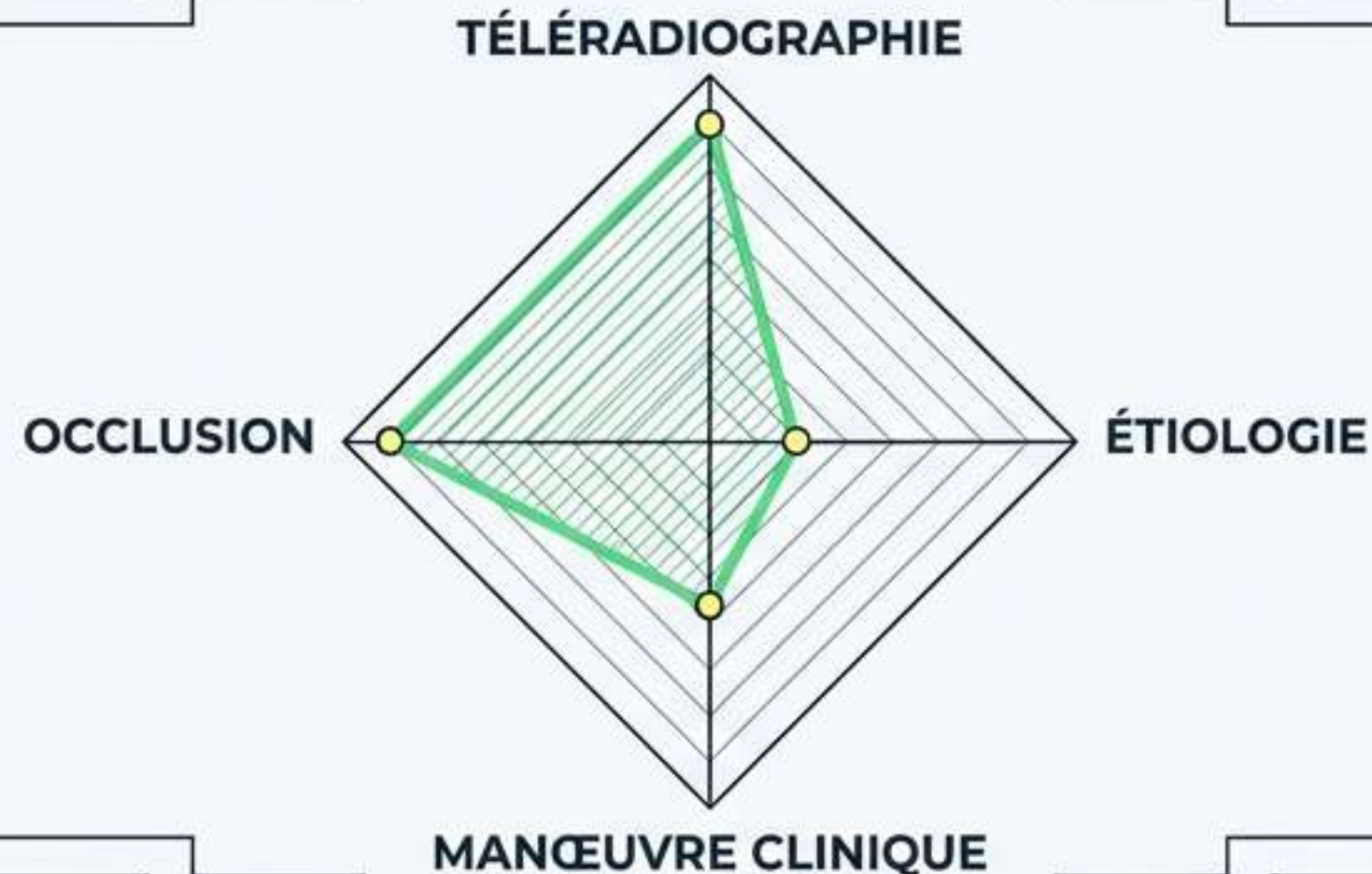
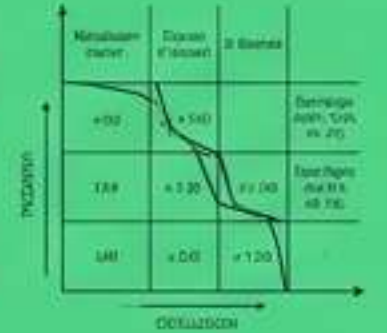
PIÈGES CLASSIQUES (EXAM TRAPS) :

- Confondre l'étiologie de la **prognathie** (souvent héréditaire) avec la **classe III fonctionnelle** (cinétique).
- La relation "**Brachygnathie = Rétrognathie**" mais l'inverse n'est pas automatique.



INDICE DE CONFIANCE PRÉDICTIVE : 95%

- Les **sous-classifications** (Typologie de Schudy) et les **valeurs téléradiographiques spécifiques** (Axe Y, FMA, AF, AC) sont les cibles imminentes.



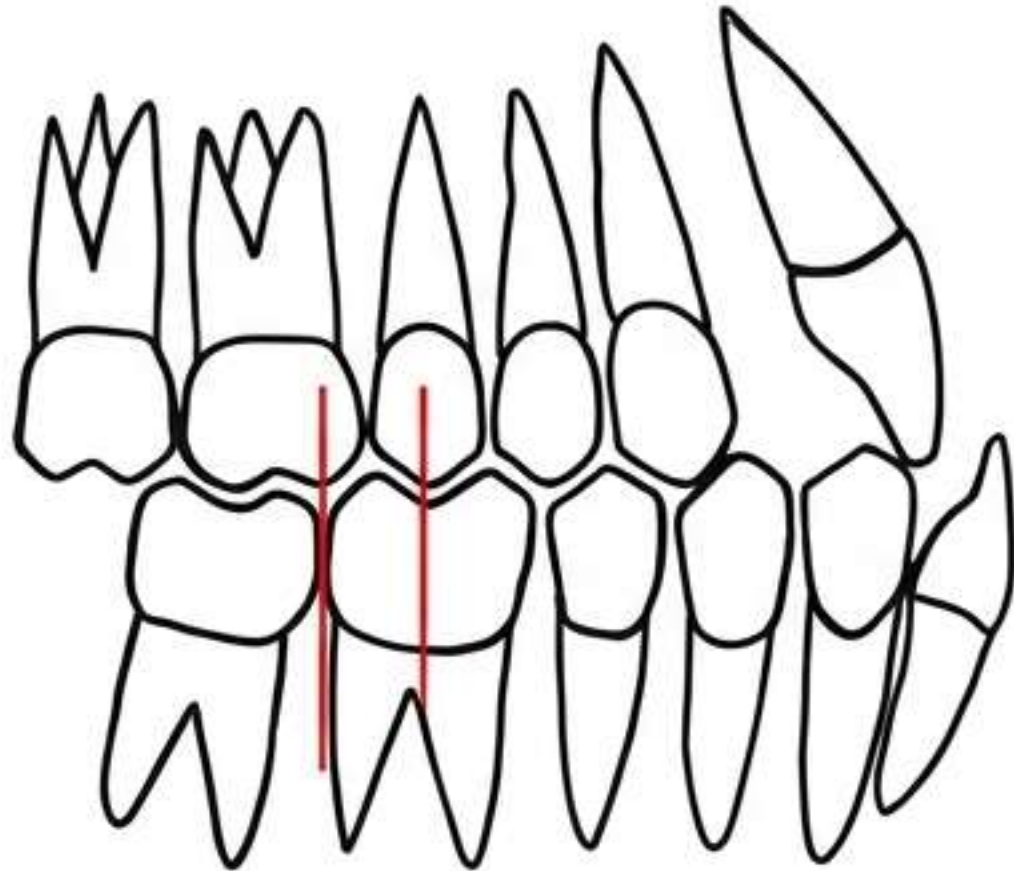
1. Définition et Caractéristiques Fondamentales

Définition Générale :

Ensemble hétérogène, rarement isolé. Historiquement appelée prognathie mandibulaire, mais la rétrognathie maxillaire est aujourd'hui la plus répandue.

Caractéristiques communes :

- Une mésioclusion plus au moins accentuée des premières molaires inférieures. [Ref: Q11, Q18, Q4 (2019)]
- Un profil concave. [Ref: Q11, Q12 (2018), Q18]
- En général, une occlusion inversée du secteur incisif. [Ref: Q11, Q19]

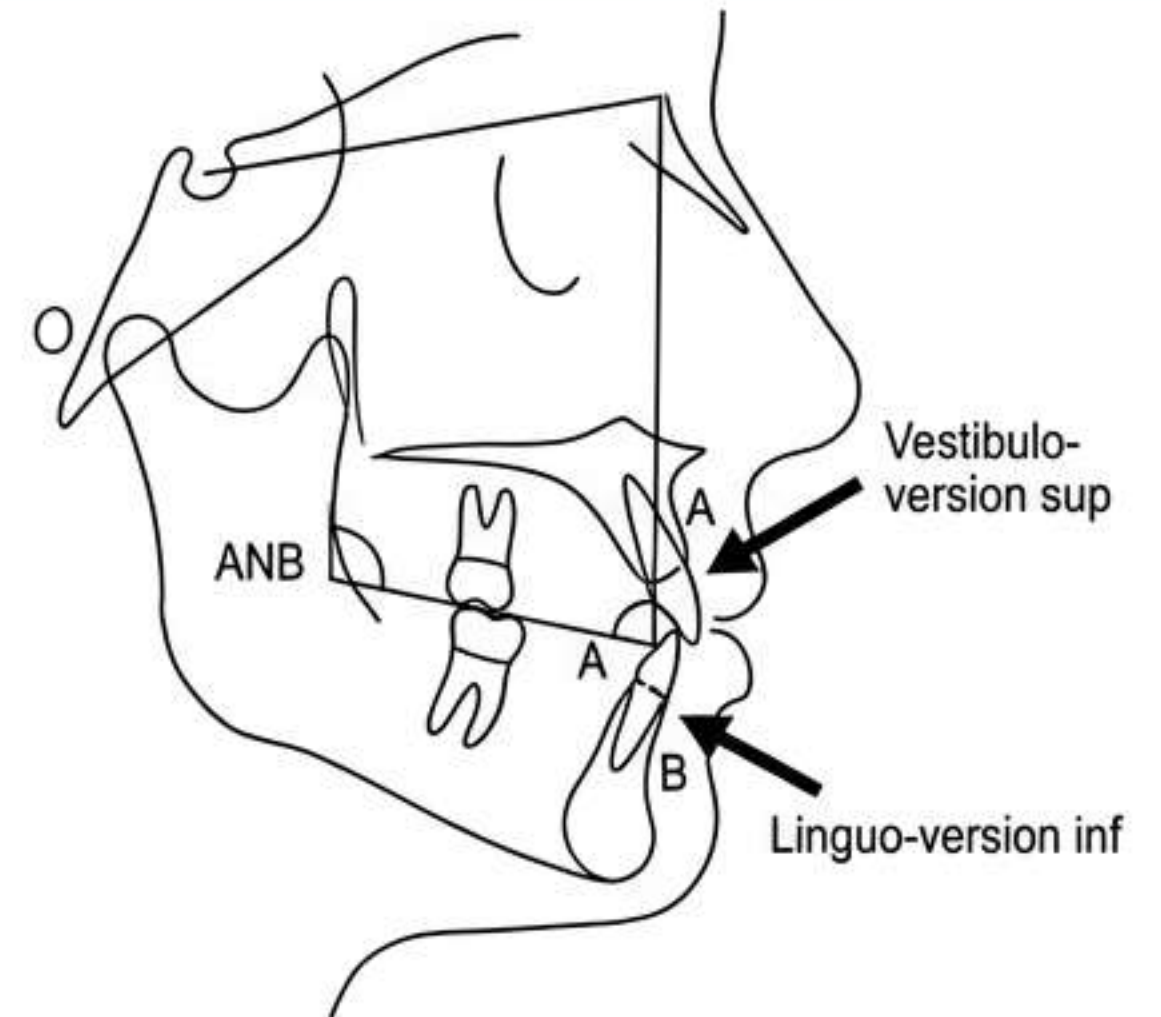


Classification des Bases Osseuses (BALLARD) :

Complète la classification d'Angle (sens sagittal / inclinaison incisive / compensations).

Selon Ballard, la classe III squelettique se caractérise par :

- Position trop antérieure de la mandibule. [Ref: Q10]
- Angle ANB diminué. [Ref: Q10, Q11 (2018), Q18]
- Légère vestibulo-version des incisives supérieures. [Ref: Q10]
- Légère linguo-version des incisives inférieures. [Ref: Q10]



2. Étiologies : Primaires vs Secondaires

Causes Primaires (D'origine héréditaire) :

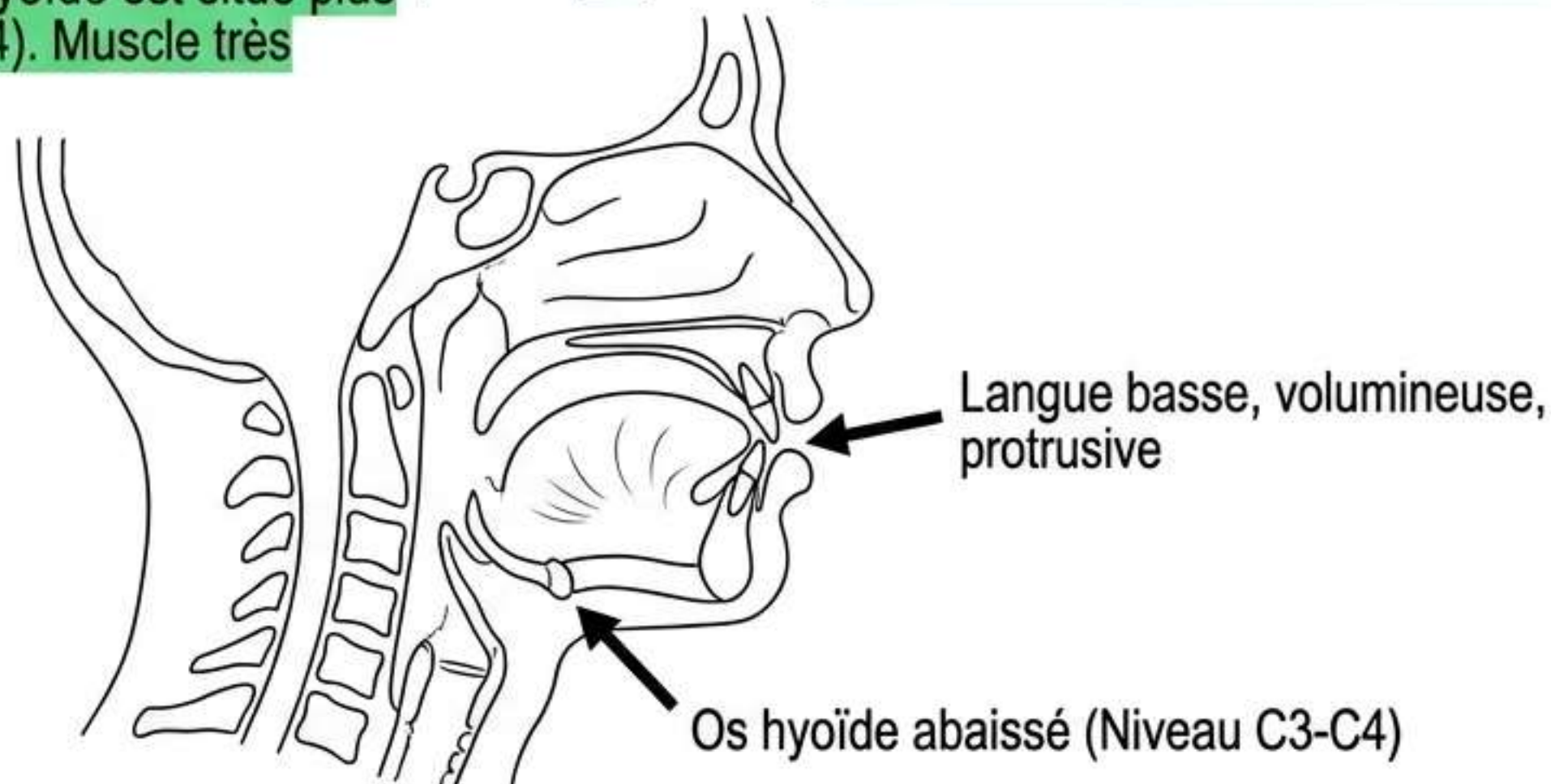
- Transmission sur un mode dominant (ex: lignée des Habsbourg). [Ref: Q48, Q12 (2019), Q18]

Le Facteur Anatomique Transmis (La Langue) :

- La langue est basse, volumineuse et protrusive. [Ref: Q49, Q9 (2019)]
- **Conséquence anatomique** : L'os hyoïde est situé plus bas que la moyenne (entre C3 et C4). Muscle très puissant.

Causes Secondaires :

- **Causes locales** : Au passage de la denture temporaire à mixte, incisives en occlusion inversée (antémandibulie).
- **Causes pathologiques** : Acromégalie ou achondroplasie (insuffisance du chondrocrâne qui se répercute sur le maxillaire).



3. Les Formes Cliniques Squelettiques (BASSIGNY)

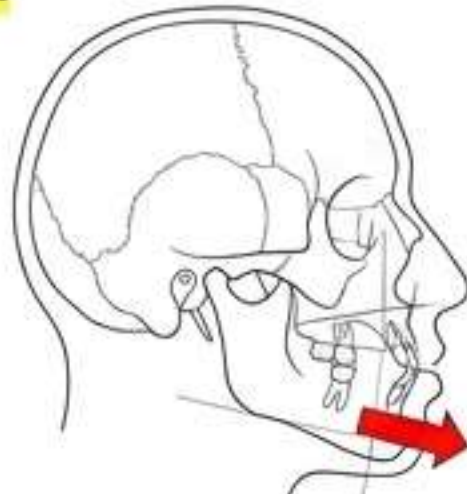
La dysmorphose peut s'accompagner d'anomalies cinétiques (proglissement, latérodéviation).
Selon **BASSIGNY**, la classe III squelettique présente 3 formes :

1. Classe III par Prognathie Mandibulaire (25%)

Selon **IZARD**, la mandibule est trop en avant. [Ref: Q16]

Trouble du développement par excès :
En longueur = Prognathie vraie.
Dans sa totalité = Prognathie hypertrophique.

Anomalie évolutive, s'aggravant avec la croissance.

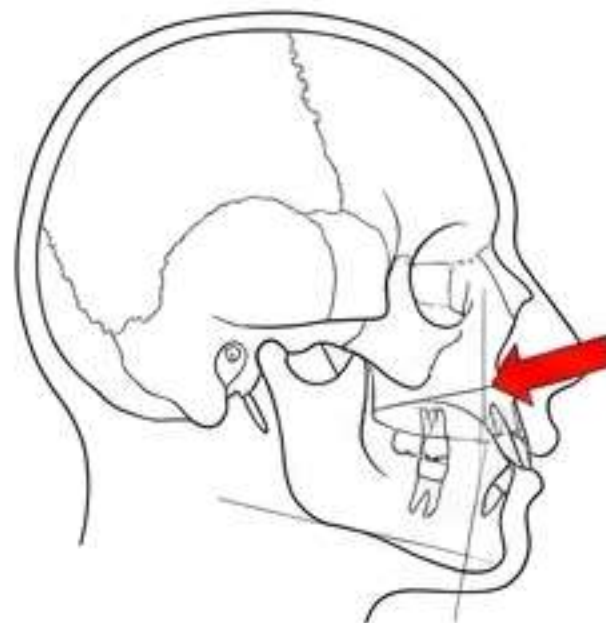


Prognathie (25%)

2. Classe III par Brachygnathie Maxillaire (65%)

Anomalie due à un trouble de croissance maxillaire. [Ref: Q8]

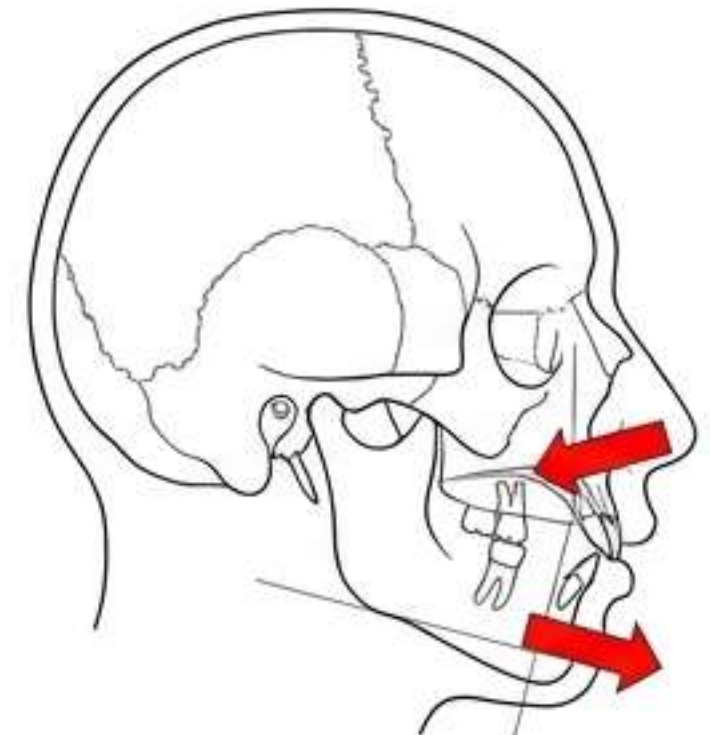
Représente la majorité des cas cliniques (Étude multicentrique de **DELAIRE**).



Brachygnathie (65%)

3. Classe III Mixte

Association des deux formes précédentes.



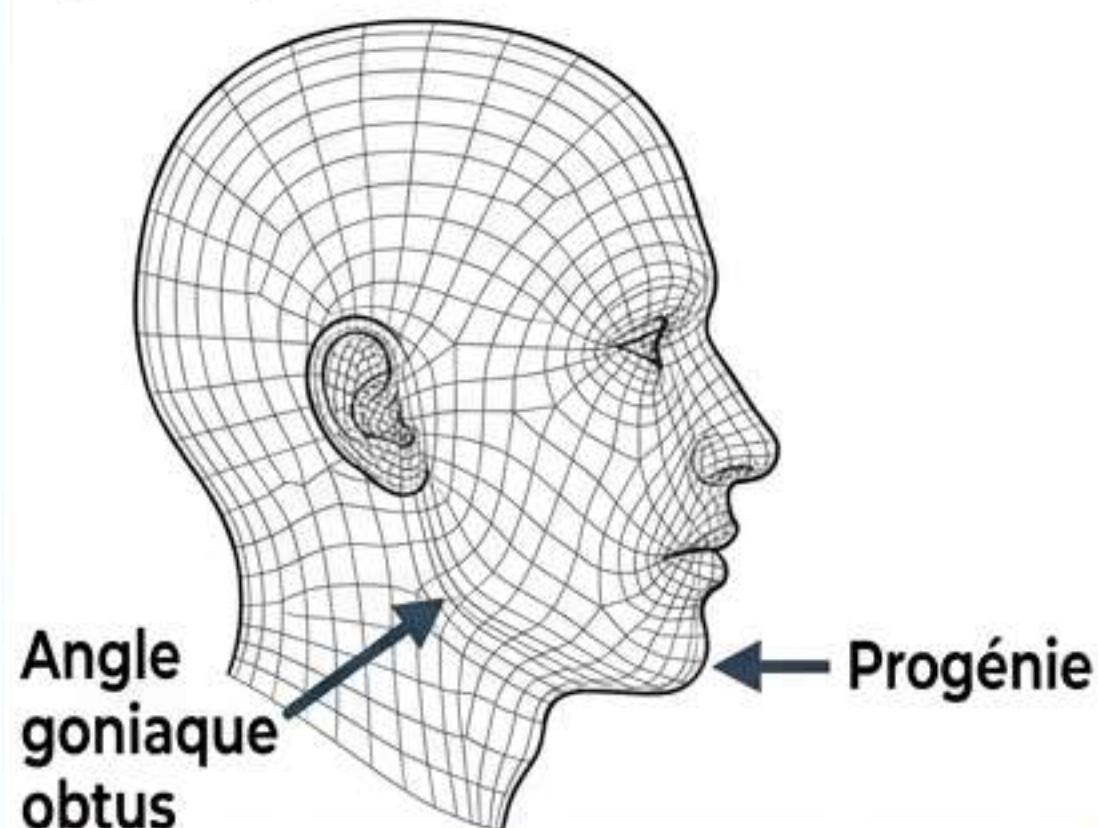
Mixte (Cas Graves)

4.1.1. Prognathie Mandibulaire Vraie : Excès Vertical (Face Longue)

Forme la plus fréquente et caractéristique.

Signes Faciaux

- Retentissement esthétique important : Concavité du profil, Face longue.
- Procheilie inférieure et progénie. [Ref : Q11 (2018)]
- Mandibule paraît très longue, angle goniale très obtus.

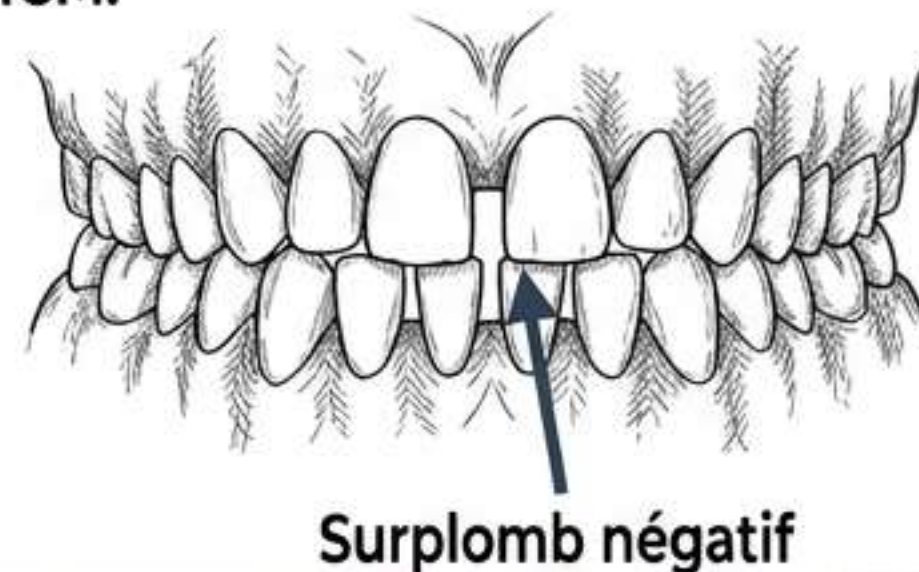


Signes Fonctionnels

- Langue basse, Respiration buccale, Déglutition primaire (arcades non serrées).
- Trouble de la mastication : le mouvement d'incision est impossible.
- Élocution avec mobilité glosso-mandibulaire anormale.

Signes Occlusaux (ICM)

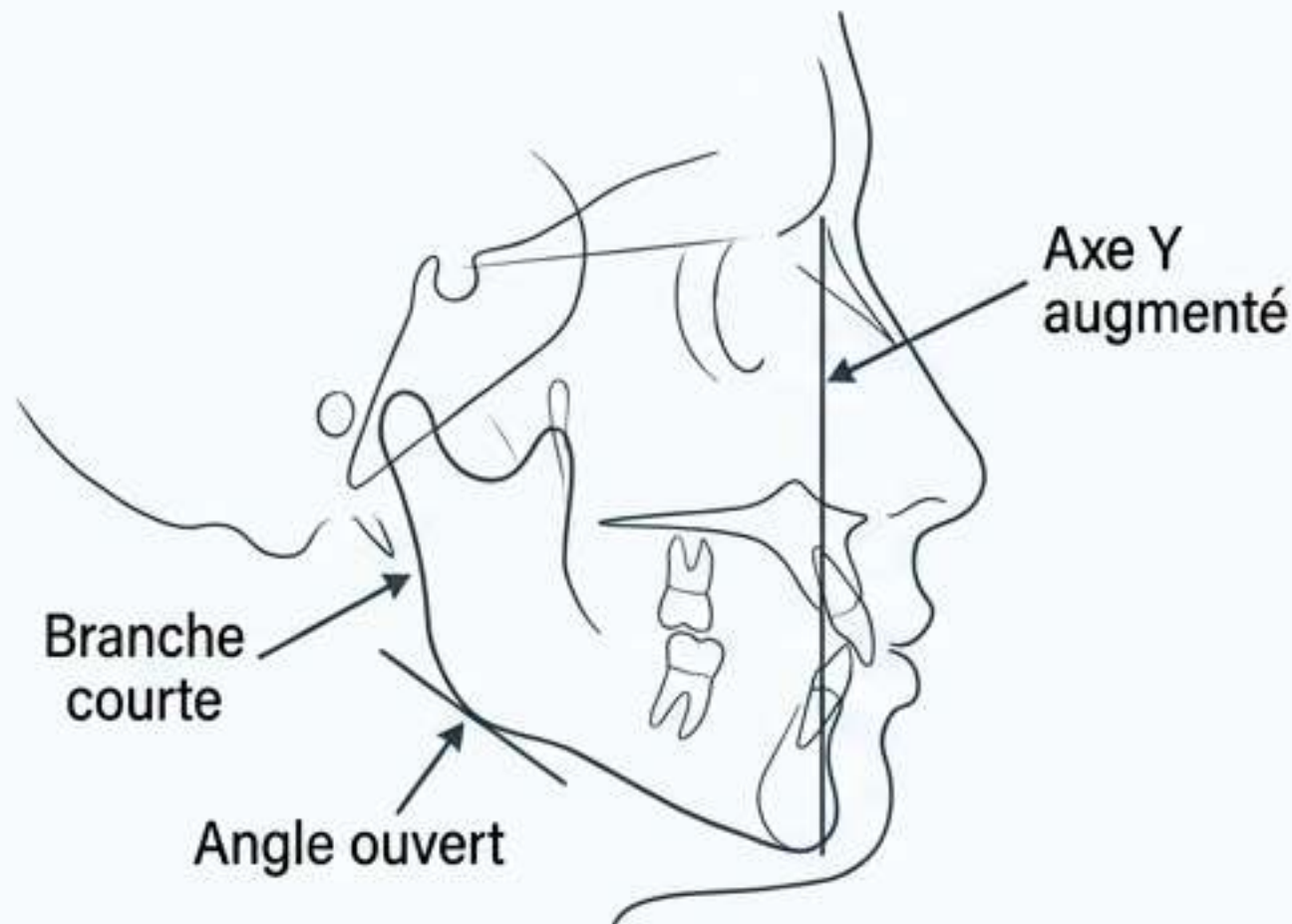
- Classe III molaire/canine prononcée, ou plan de Chapman à marche mésiale en denture temporaire.
- Occlusion inversée antérieure avec surplomb négatif important [Ref : Q19] (bout à bout possible par compensation alvéolaire).
- Diastèmes fréquents. Béance antérieure ou supraclusion possible. Relation centrée (RC) coïncide avec ICM.



Téléradiographie : Excès Vertical (Face Longue) vs Excès Horizontal (Face Courte)

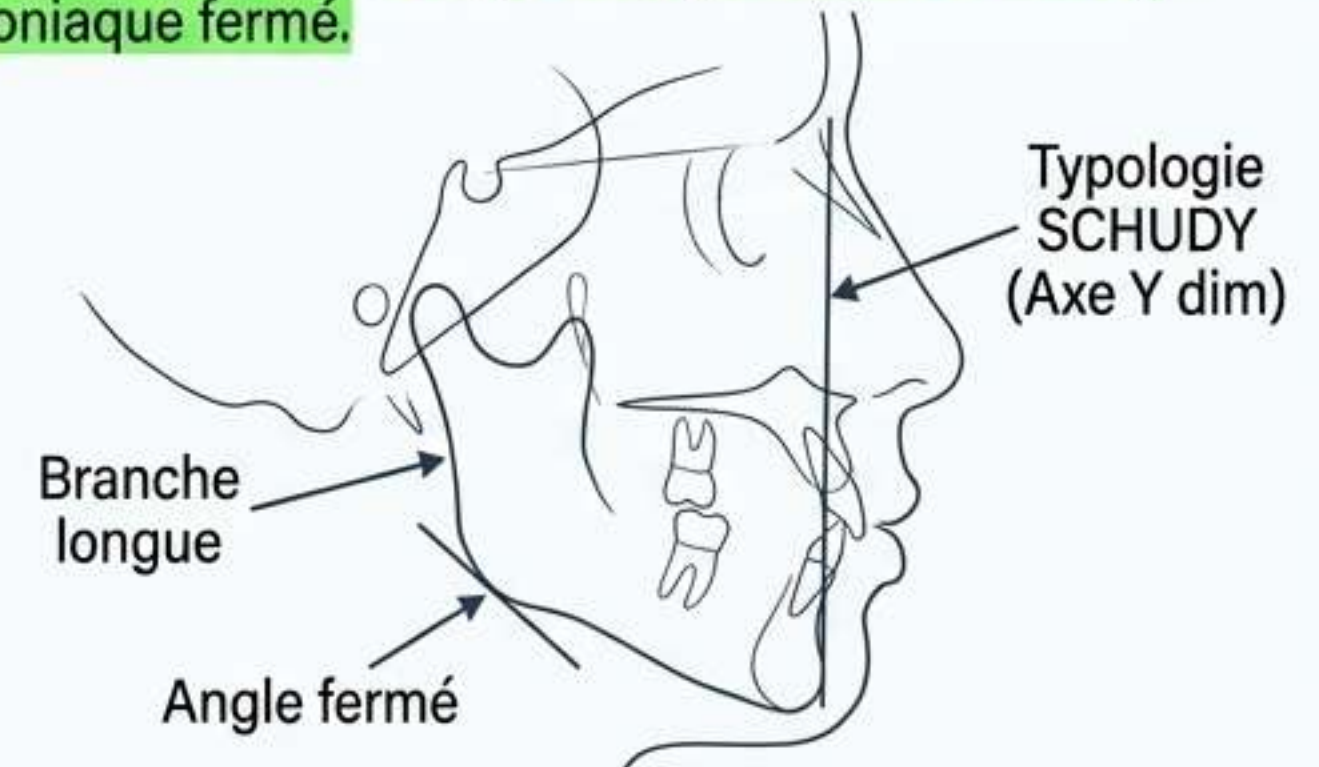
Prognathie Excès Vertical (Face Longue)

- Branche montante courte/étroite, condyle grêle orienté vers l'arrière.
- Corps mandibulaire long, Angle goniale très ouvert.
- Axe Y et FMA augmentés ; AC diminué, AF augmenté.
- ANB diminué, SNA normal, SNB augmenté, A'B' négatif.
[Ref: Q7, Q11 (2018), Q19]



4.1.2. Prognathie Excès Horizontal (Face Courte)

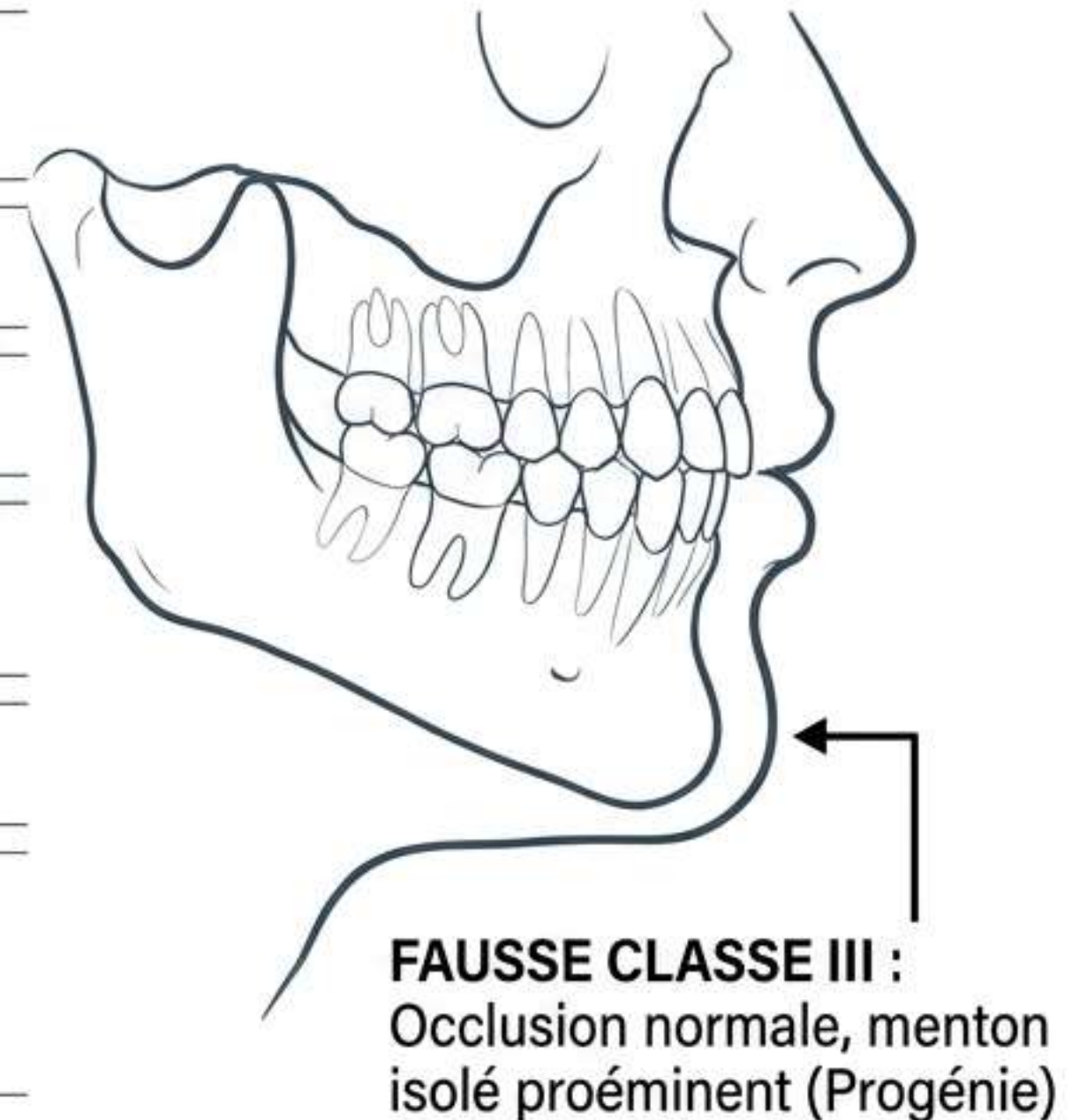
- **Faciaux** : Face courte, profil concave, angle goniale très fermé, prochéilie inf/progénie.
- **Occlusaux** : Identiques à face longue, MAIS avec supraclusion incisive toujours associée.
- **Fonctionnels** : Position linguale moyenne, respiration/déglutition normales.
- **TLR** : SNB très augmenté. Branche montante longue, hauteur verticale post. diminuée, symphyse marquée.
- Axe Y diminué (Typologie hypodivergente de SCHUDY), Angle goniale fermé.



4.1.3. Diagnostic Différentiel de la Prognathie Mandibulaire

La prognathie mandibulaire vraie doit être différenciée cliniquement et radiographiquement de :

[]	1. La classe III fonctionnelle ou proglissement mandibulaire (mise en évidence par manœuvre de DENEVREZE). [Ref: Q9]	☐
	2. La classe I avec proalvéolie inférieure (i/m augmenté). [Ref: Q9]	☐
	3. La classe I avec rétroalvéolie supérieure (I/F diminué). [Ref: Q9]	☐
[]	4. La classe III par brachygnathie maxillaire ou à responsabilité bimaxillaire.	☐
	5. La classe I mixte (rétroalvéolie sup + proalvéolie inf).	☐
[]	6. Progénie ou macrogénie : Hyperdéveloppement isolé de la saillie mentonnière (souvent héréditaire) qui simule une classe III par la concavité du profil, sans anomalie basale globale.	☐

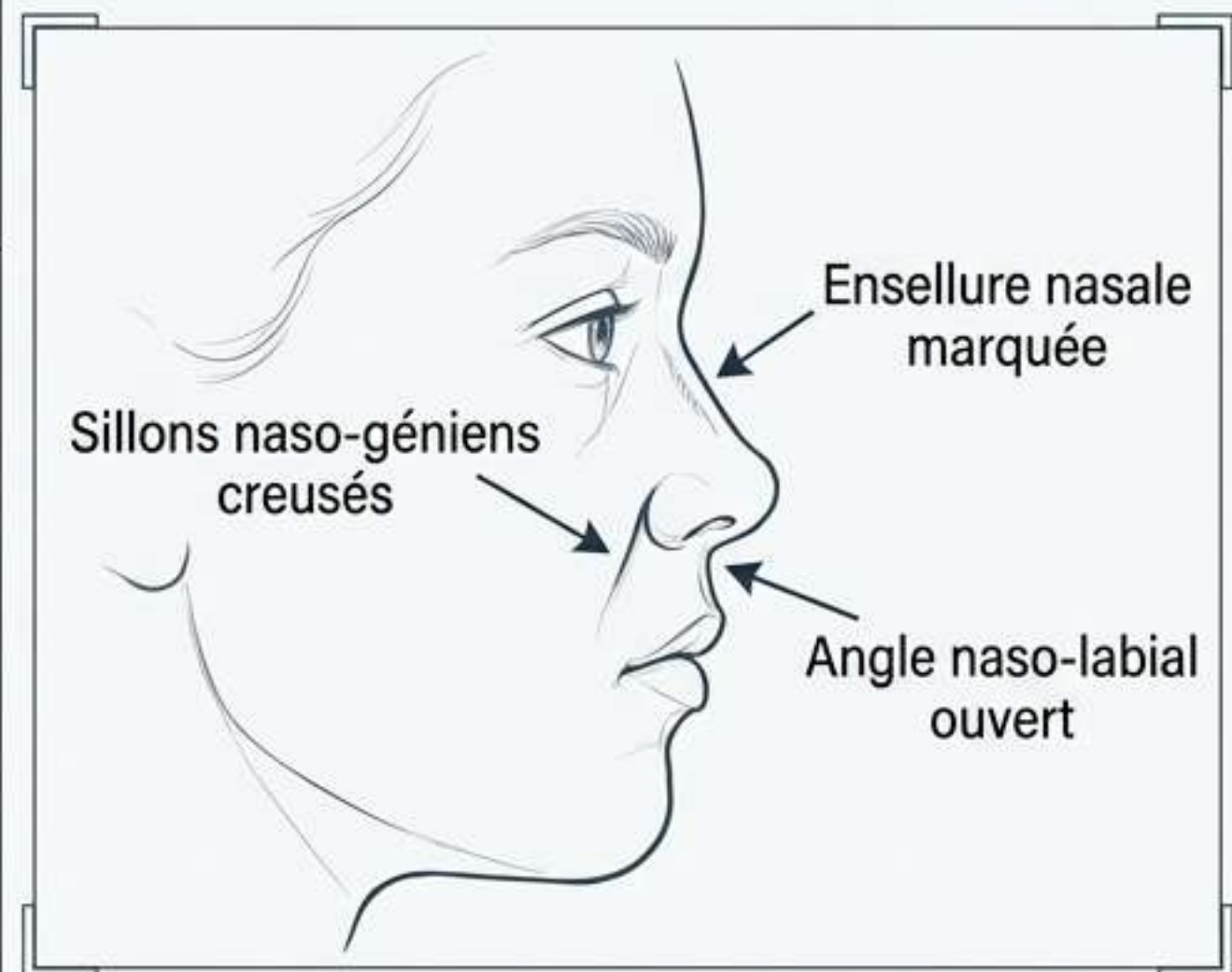


4.2. Classe III Squelettique par Brachygnathie Maxillaire (65%)

Observable dès 4-8 ans. Anomalie basale due à une insuffisance de développement (total ou antérieur) du maxillaire.

Signes Faciaux :

- Diminution de l'étage moyen ; partie moyenne plate.
- **Sillons naso-géniens creusés avec pli de jonction ailes nasaires/joues** = signe quasi pathognomonique, absence de relief des pommettes.
- **Lèvre supérieure fine, rétrochéilie supérieure.** [Ref: Q1]
- Lèvre inférieure épaisse/éversée. Nez petit avec orifice narinaire apparent (hypofonctionnement ventilatoire). Angle naso-labial ouvert, courbure sous-narinaire allongée, ensellure nasale marquée.
- Test d'évaluation : La « Vue d'avion » (Bird's eye) (praticien derrière l'enfant). Le creux paranasal et la lèvre sup sont en arrière de la lèvre inf.

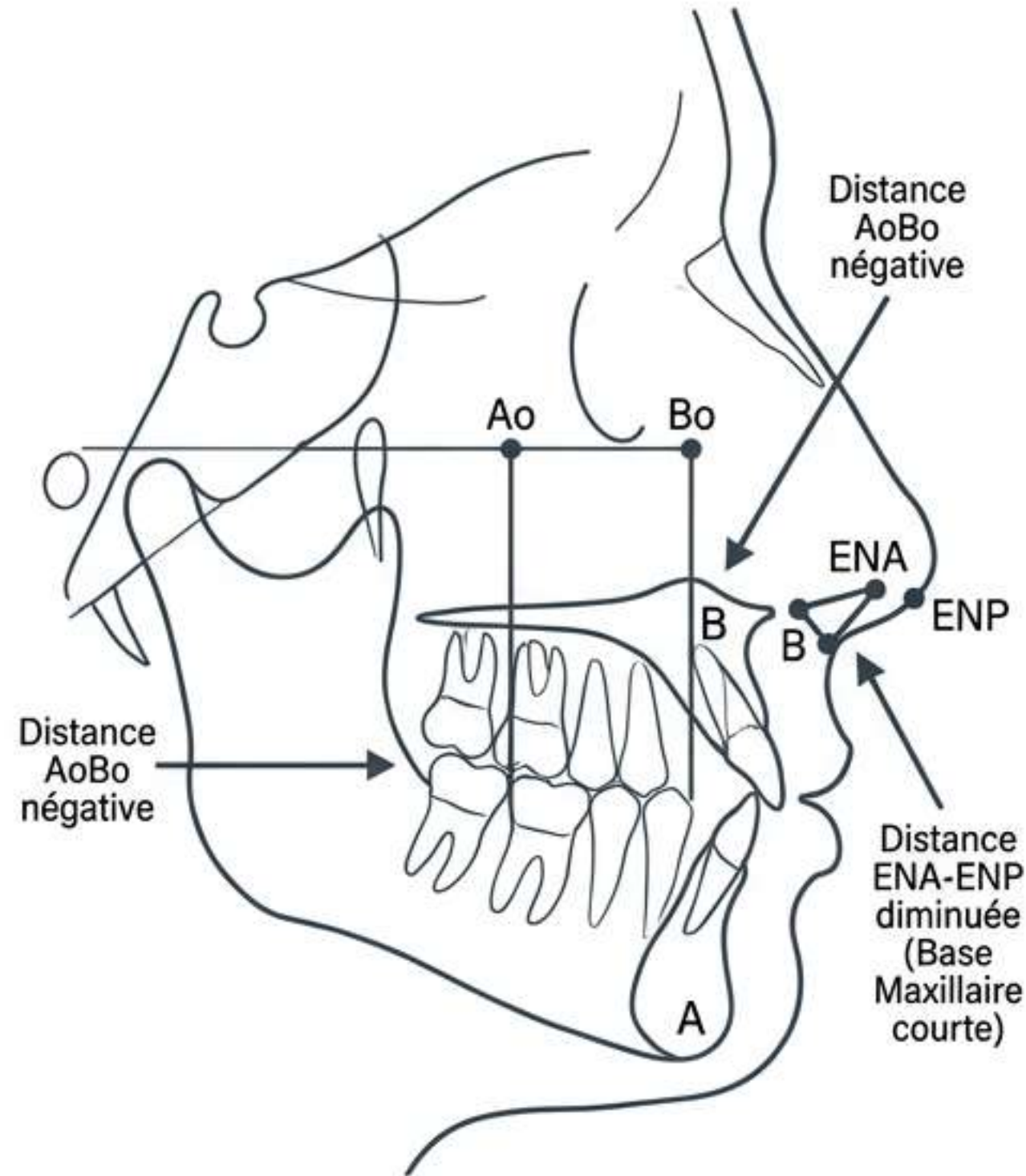


Brachygnathie Maxillaire :

Signes Occlusaux et Céphalométriques

Signes Occlusaux & Fonctionnels

- DDM supérieure. Respiration souvent buccale, déglutition atypique, mastication perturbée.
- Occlusion antérieure inversée, Classe III canine/molaire. [Ref: Q9 (2016)]
- Langue basse en arrière des incisives mandibulaires au repos. [Ref: Q17]



Signes Téléradiographiques (TLR)

- SNA diminué. SNB normal. ANB diminué. [Ref: Q12]
- I/F diminué. [Ref: Q1, Q12, Q9 (2016)]
- AC diminué. Distance AoBo est négative.
- Longueur de base maxillaire (distance ENA - ENP) est diminuée sur TLR et sur moulage.

Étiologies et Diagnostic Différentiel (Braihygnathie Maxillaire)

Étiologies :

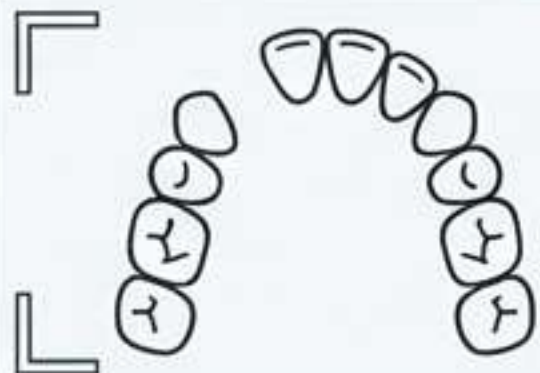
L'hérédité est la seule cause bien établie. Autres causes incriminées :

- Agénésie des incisives latérales supérieures (diminue volume du prémaxillaire).
- Position basse de la langue ou langue petite (pas d'effet stimulant sur le maxillaire) avec trouble de respiration. [Ref: Q8, Q17]
- Fentes labio-palatines (bride cicatricielle empêchant le développement maxillaire).
- Fracture maxillaire négligée.

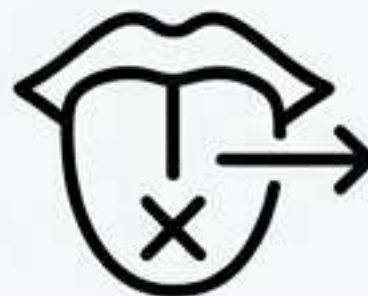
Diagnostic Différentiel :

Doit être différenciée de :

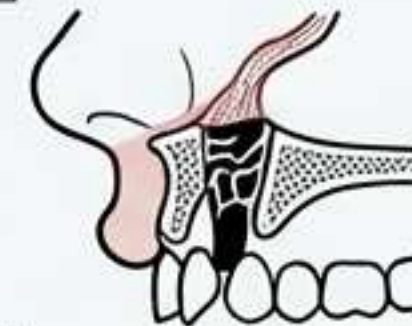
- Prognathie, Mixte, Fonctionnelle, Cl. I (rétroalvéolie sup, proalvéolie inf).
- **Concept clé** : La classe III par rétrognathie maxillaire (une brachygnathie correspond à une rétrognathie, mais PAS le contraire).



Agénésie



Langue
petite



Fente / Bride
cicatricielle

4.3 Forme Mixte & 4.4 Classe III Fonctionnelle

4.3. La Forme Mixte :

- Associe **brachygnathie maxillaire** (parfois avec endognathie maxillaire) + **prognathie inférieure**. Ce sont les cas les plus graves et difficiles à corriger.

4.4. La Classe III Fonctionnelle (Antémandibulie / Proglissement) :

- **Fausse classe III**. Anomalie fonctionnelle sans trouble squelettique, en rapport avec la cinétique mandibulaire (position antérieure en occlusion terminale). [Ref: Q3, Q16 (2015)]
- **Risque** : S'anatomiser (devenir une cause de prognathie vraie). Nécessite interception précoce.

La Manœuvre de DENEVREZE :

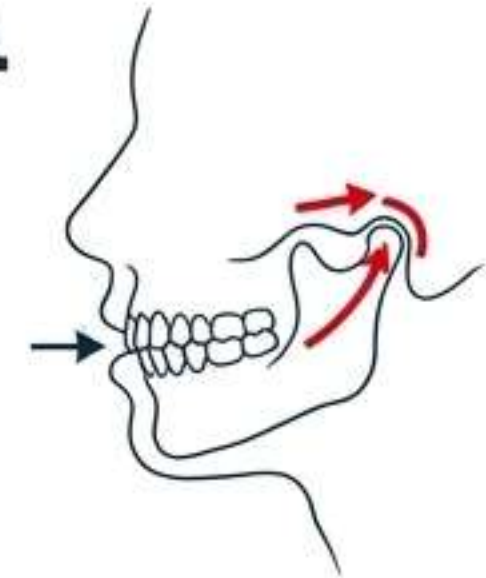
- **Confirme le proglissement**. [Ref: Q16 (2015)]
- **Technique** : Appuyer sur le menton en ouverture, tête légèrement fléchie en arrière, provoquer la fermeture. Résultat positif = recul de la mandibule, condyles remis au fond de la cavité glénoïde, contact prématuré mis en évidence.

Schéma Biomécanique de la Manœuvre de Denevreze

1.



2.



Recul mandibulaire & Repositionnement condylien

La Classe III Fonctionnelle : Signes et Étiopathogénie

Signes Faciaux & TLR

- **Faciaux** : Profil concave, menton/lèvre inf déportés en avant. Signes diminuent au repos !
- **TLR** : ANB, SNA, SNB normaux. Mandibule taille normale. [Ref: Q3]

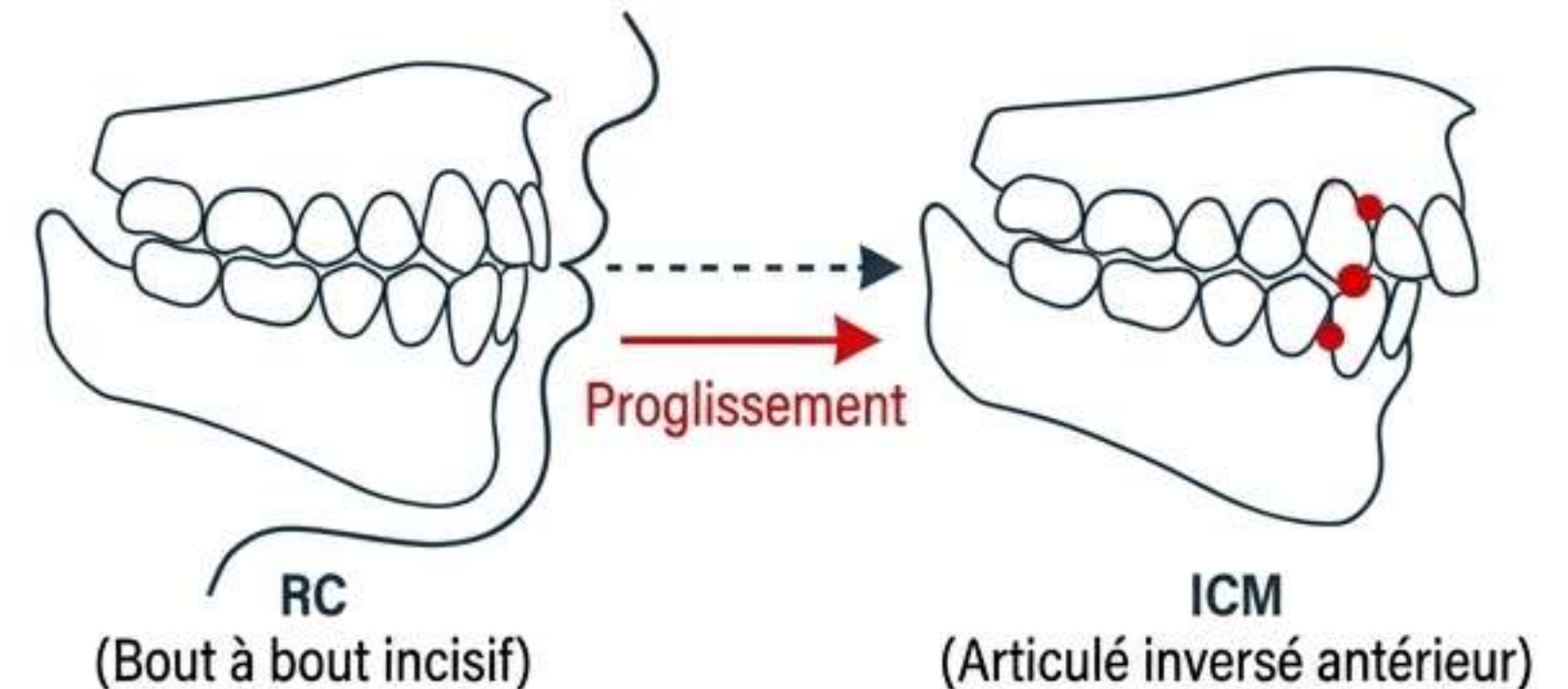
Signes Occlusaux

- **En ICM** : Articulé inversé antérieur, classe III molaire/canine, chemin de fermeture dévié vers l'avant.
- **En Relation Centrée (RC)** : Bout à bout incisif. [Ref: Q6]
- **Au repos** : Aucun signe d'anomalie.
Moulages : absence de compensation.

Étiopathogénie (Pourquoi glisse-t-elle ?)

- Absence de guide antérieur (cause la plus fréquente).
- Pré maturités occlusales (canines temporaires non abrasées).
- Proalvéolie inf, Rétroalvéolie sup, Brachygnathie maxillaire.
- Propulsion par mimétisme.
- Ventilation buccale, mastication altérée. [Ref: Q16 (2015)]
- Macroglossie ou hypertrophie amygdalienne (dégage carrefour aérodigestif). [Ref: Q49]

Le Mécanisme (Chemin de Fermeture)



5. Le Pronostic & 6. Conclusion

L'interception de la Classe III doit être précoce et vise à rétablir un guide incisif. [Ref: Q8 (2019)]

1. L'âge :

Un traitement précoce, idéalement avant la puberté, est plus efficace et donne des résultats plus stables.

2. La sévérité de la malocclusion :

Des décalages squelettiques importants nécessiteront une approche chirurgicale à la fin de la croissance.

3. L'étiologie :

Origine héréditaire = pronostic réservé.
Origine fonctionnelle = traitement orthopédique très efficace.

4. La collaboration du patient :

Bonne compliance essentielle pour de meilleurs résultats.



Conclusion :

Selon RICKETTS : « L'observation qui n'est pas guidée par des idées est aveugle ».

L'orthodontiste doit éduquer son regard (l'œil observateur). La – collecte rigoureuse suivie d'une interprétation précise aboutit au diagnostic complet, base absolue du schéma thérapeutique.

Mind Map de Synthèse Diagnostique

Excès Vertical : Face longue, angle goniale ouvert, Y/FMA aug.



Excès Horizontal : Face courte, angle goniale fermé, Y dim (Schudy), supraclusion.



Prognathie Mandibulaire (25%)



Brachygnathie Maxillaire (65%)



Signes : Sillons naso-géniens, Bird's eye.

TLR : SNA dim, SNB normal, ENA-ENP dim, AoBo neg.



CLASSE III



(Ballard : Mandibule ant, ANB dim, Vestibulo sup, Linguo inf).

Mécanisme : Pré maturités / Amygdales.



Preuve : Manœuvre de Denevrez (+), Bases osseuses normales (SNA/SNB normaux). Bout à bout en RC.



Classe III Fonctionnelle (Proglissement)